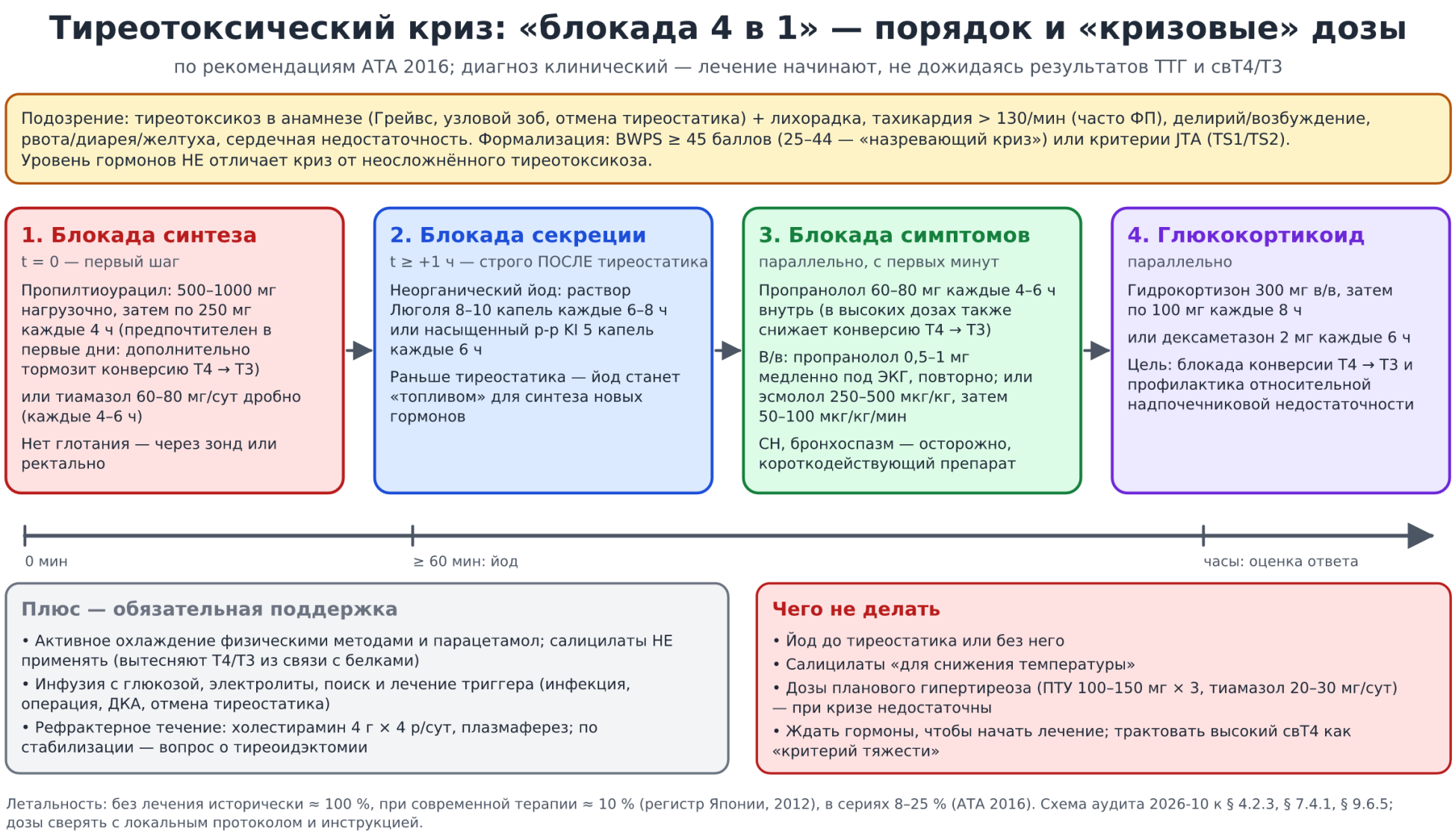
ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ТЕПЛОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Пояснительные схемы содержательного аудита 2026-10 (PNG, 2400 × 1350)

№	Схема	Разделы монографии	Файл
1	Тиреотоксический криз: «блокада 4 в 1» — порядок и дозы	§ 9.6.5	assets/audit/01-tireotoksicheskiy-kriz-4v1.png
2	Критерии нейролептического злокачественного синдрома: три системы	§ 7.8.1	assets/audit/02-kriterii-nzs.png
3	Злокачественная гипертермия: ранние, развёрнутые и поздние признаки	§ 5.4.2, § 4.2.1, § 7.8.3	assets/audit/03-zlokachestvennaya-gipertermiya-priznaki.png
4	Лихорадка у младенца до 3 месяцев: два устоявшихся подхода	§ 7.4.1, § 12.1	assets/audit/04-likhoradka-mladenec-do-3-mes.png
5	Судороги на фоне гипертермии: лестница терапии и дозы	§ 9.5.4, § 12.1.5, § 14.5	assets/audit/05-sudorogi-lestnica-terapii.png
6	Две модели терморегуляции: «установочная точка» и «точка равновесия»	§ 2.1.1	assets/audit/06-dve-modeli-termoregulyacii.png
7	Спектр тепловых поражений: от тепловых судорог до теплового удара	§ 4.3	assets/audit/07-spektr-teplovyh-porazheniy.png
8	Карта аудита 2026-10: исправления, разные мнения, современные положения	АУДИТ-2026-10.md	assets/audit/08-karta-audita.png

Исходники — SVG в том же каталоге (assets/audit/*.svg), генераторы — scripts/audit_schemes/. Схемы являются пояснительными; дозы и критерии следует сверять с текстом монографии, локальным протоколом и инструкцией к препарату. Визуальные сводки глав (Mermaid) включены в PDF монографии.

Схема 1. Тиреотоксический криз: «блокада 4 в 1» — порядок и дозы



Относится к: § 9.6.5 · файл assets/audit/01-tireotoksicheskiy-kriz-4v1.png

Схема 2. Критерии нейролептического злокачественного синдрома: три системы

Критерии НЗС: три сосуществующие системы

ни одна из них не является «критериями DSM-5»: в DSM-5 (2013) формального алгоритма нет, его описание согласовано с консенсусом 2011 года

Levenson, 1985

классические клинические критерии

Большие (3):

- лихорадка
- ригидность
- повышение КФК

Малые (6):

- тахикардия
- аномальное АД
- тахипноэ
- изменение сознания
- потливость
- лейкоцитоз

Диагноз вероятен:

3 больших ИЛИ 2 больших + 4 малых

Условие: приём нейролептика (или отмена дофаминергического препарата)

DSM-IV-TR, приложение B

исследовательские критерии (чаще всего ошибочно цитируются как «DSM-5»)

А. Обязательно оба:

- тяжёлая мышечная ригидность
- повышение температуры

на фоне приёма нейролептика

Б. Два и более из:

- потливость • дисфагия • тремор
- недержание • изменение сознания
- мутизм • тахикардия
- повышенное или лабильное АД
- лейкоцитоз
- лабораторные признаки повреждения мышц (КФК)

В. Не объясняется другим веществом, неврологическим или соматическим заболеванием

Консенсус 2011 (Gurrera et al.)

международный экспертный консенсус, метод Дельфи; баллы приоритета (сумма 100)

- Антагонист дофамина / отмена агониста за 72 ч — 20
- Гипертермия > 38,0 °C при ≥ 2 измерениях — 18
- Ригидность — 17
- Изменение психического статуса — 13
- КФК ≥ 4 × ВГН — 10
- Вегетативная лабильность (≥ 2 из: АД +25 %, колебания АД ≥ 20/25 мм рт. ст., потливость, недержание) — 10
- Гиперметаболизм: ЧСС ≥ 125 % И ЧД ≥ 150 % от исходных — 5
- Исключены инфекционные, токсические, метаболические, неврологические причины — 7

Валидация (Gurrera, 2017): порог ≥ 74 баллов

Для неотложной помощи

Ни одна система не требует «полного набора» признаков, чтобы начать лечение: при обоснованном подозрении (нейролептик + ригидность + гипертермия/вегетативная нестабильность) триггер отменяют и начинают охлаждение и поддерживающую терапию немедленно (§ 9.6.2). Шкалы нужны для документирования, дифференциальной диагностики с серотониновым синдромом и исследований.

Схема аудита 2026-10 к § 7.8.1. Источники: Levenson JL, Am J Psychiatry 1985; DSM-IV-TR (2000); Gurrera RJ et al., J Clin Psychiatry 2011; Gurrera RJ et al., J Clin Psychopharmacol 2017.

Относится к: § 7.8.1 · файл assets/audit/02-kriterii-nzs.png

Схема 3. Злокачественная гипертермия: ранние, развёрнутые и поздние признаки



Схема аудита 2026-10 к § 4.2.1, § 5.4.2, § 7.8.3, § 9.7.3. Шкала CGS (Larach, 1994): ≥ 50 баллов — «МН почти несомненна»; в остром периоде диагноз клинический, баллов не ждут.

Относится к: § 5.4.2, § 4.2.1, § 7.8.3 · файл assets/audit/03-zlokachestvennaya-gipertermiya-priznaki.png

Схема 4. Лихорадка у младенца до 3 месяцев: два устоявшихся подхода



Схема аудита 2026-10 к § 7.7. Источники: Pantell RH et al., AAP Clinical Practice Guideline, Pediatrics 2021; NICE NG143 (2019+). Локальный протокол имеет приоритет.

Относится к: § 7.4.1, § 12.1 · файл assets/audit/04-likhoradka-mladenec-do-3-mes.png

Схема 5. Судороги на фоне гипертермии: лестница терапии и дозы



Схема аудита 2026-10 к § 9.5.4, § 12.1.5, § 12.1.6, § 14.5. Дозы сверять с локальным протоколом и инструкцией к препарату.

Относится к: § 9.5.4, § 12.1.5, § 14.5 · файл assets/audit/05-sudorogi-lestnica-terapii.png

Схема 6. Две модели терморегуляции: «установочная точка» и «точка равновесия»



Схема аудита 2026-10 к § 2.1.1 (примечание «Две модели одного термостата»).

Относится к: § 2.1.1 · файл assets/audit/06-dve-modeli-termoregulyacii.png

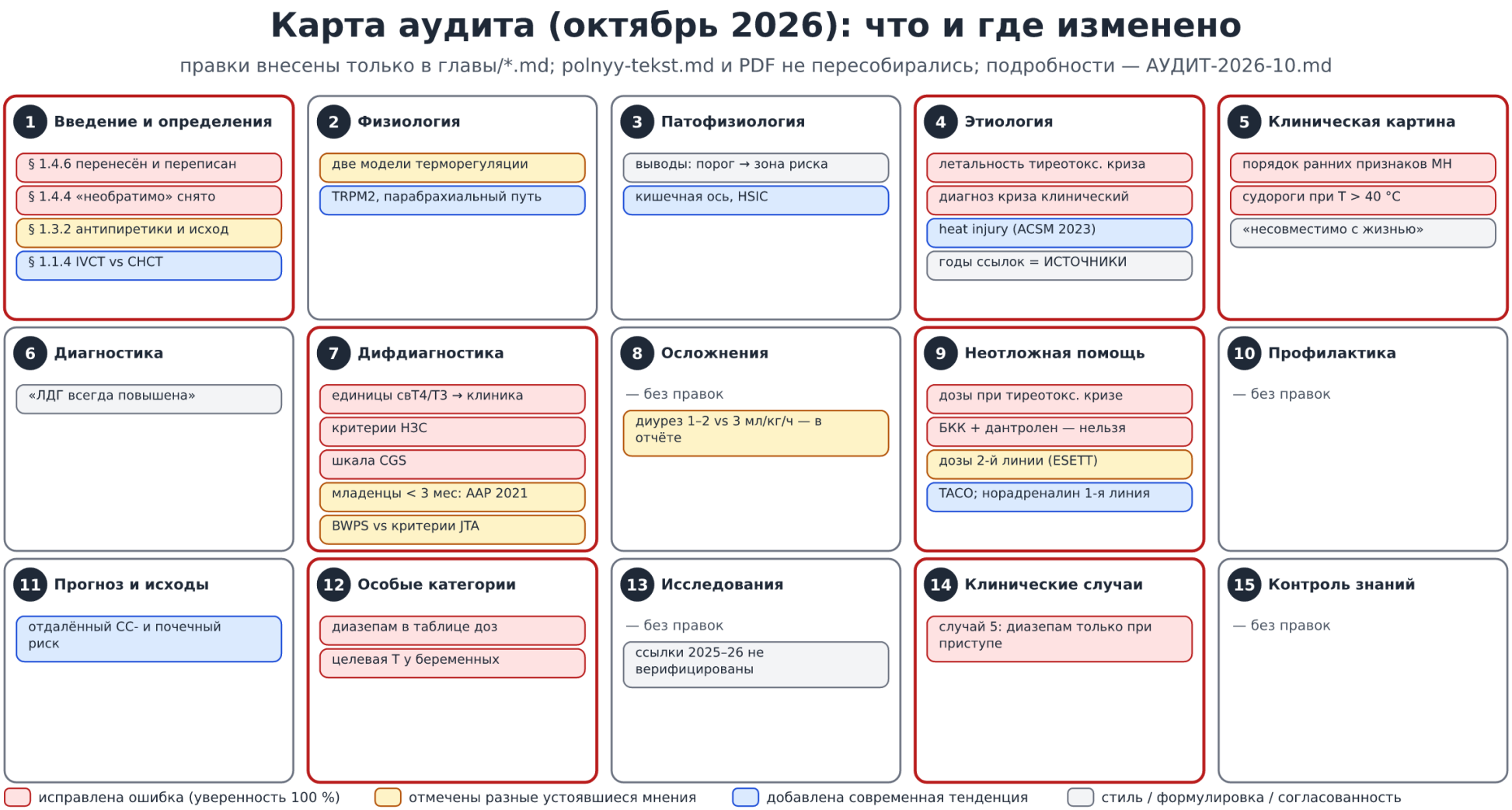
Схема 7. Спектр тепловых поражений: от тепловых судорог до теплового удара



Схема аудита 2026-10 к § 4.3.4. Границы температуры ориентировочные; разделяющий признак — ЦНС (тепловой удар) и объективное повреждение органов (тепловое повреждение).

Относится к: § 4.3 · файл assets/audit/07-spektr-teplovyh-porazheniy.png

Схема 8. Карта аудита 2026-10: исправления, разные мнения, современные положения



Все схемы аудита: assets/audit/*.svg (источник) и *.png (экспорт resvg, 2400 × 1350).

Относится к: АУДИТ-2026-10.md · файл assets/audit/08-karta-audita.png